

ENSEIGNEMENT DU MODULE DE SEMIOLOGIE MEDICALE 2026-2027

PSYCHOLOGIE DE LA DOULEUR

S . Zeroual
Oncologie médicale
CLCC d'Oran

Plan du cours

- Définition
- Mécanismes de la douleur
- Echelles d'évaluation
- Methodes de compréhension de la douleur
- Prise en charge de la douleur aigue et chronique
- conclusions

Définition

- ❖ Expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable, associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel ou simplement décrit en termes d'un tel dommage».
- ❖ La douleur se définit donc comme un vécu, un phénomène perceptif, neuropsychologique.
- ❖ Cette définition montre la double dimension sensorielle et émotionnelle de la douleur

Mécanismes de la douleur

Excès de nociception

Excès de stimulation de nocicepteurs.

- Par envahissement tumoral
 - Osseux
 - Nerveux
 - Viscéral
 - Vasculaire
- Par inflammation (subst. algogènes)

> 3/4

Neurogène*

Atteinte de fibres nerveuses : Informations atypiques sur un territoire nerveux

- Compression ou destruction tumorale
- Toxicité des thérapeutiques sur les terminaisons nerveuses ou la gaine de myéline

< 1/4

Composante psychogène

* par désafférentation

Mécanismes de la douleur

	Nociception	Neuropathique
Sémiologie	Rythme mécanique (augmenté par activité physique) ou inflammatoire (réveil nocturne)	Douleur continue (brûlure) Douleur fulgurante (décharge électrique) Fourmillements, picotements
Topographie	Régionale	Compatible avec une origine neurologique périphérique ou centrale
Examen clinique	Examen neurologique normal	Hypoesthésie, anesthésie ou allodynie

Souvent mixte



"La douleur aux âges extrêmes de la vie reste
insuffisamment reconnue et traitée"

ÉCHELLE D'OBSERVATION

ÉCHELLE D'OBSERVATION

Signes directs de la douleur

Position antalgique au repos et dans le mouvement
Protection des zones douloureuses
Plaintes avec localisation des zones douloureuses
Réaction durant les examens des zones douloureuses

Atonie psychomotrice

Résignation
Repli sur soi
Apathie
Lenteur et rareté des mouvements

Anxiété

Nervosité, agressivité, irritabilité
Pleurs fréquents
Contrôle lors de la mobilisation

Le questionnaire HADS

(Hospital Anxiety and Depression Scale)

Score	Anxiété	Score	Dépression
3 2 1 0	Je me sens tendu ou énervé : ☐ la plupart du temps ☐ souvent ☐ de temps en temps ☐ jamais	0 1 2 3	Je prends plaisir aux mêmes choses qu'autrefois : ☐ oui, tout autant ☐ pas autant ☐ un peu seulement ☐ presque plus
3 2 1 0	J'ai une sensation de peur comme si quelque chose d'horrible allait m'arriver : ☐ oui, très nettement ☐ oui, mais ce n'est pas grave ☐ un peu, mais cela ne m'inquiète pas ☐ pas du tout	0 1 2 3	Je ris facilement et vois le bon côté des choses : ☐ autant que par le passé ☐ plus autant qu'avant ☐ vraiment moins qu'avant ☐ plus du tout
3 2 1 0	Je me fais du souci : ☐ très souvent ☐ assez souvent ☐ occasionnellement ☐ très occasionnellement	3 2 1 0	Je suis de bonne humeur : ☐ jamais ☐ rarement ☐ assez souvent ☐ la plupart du temps
0 1 2 3	Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sentir décontracté : ☐ oui, quoi qu'il arrive ☐ oui, en général ☐ rarement ☐ jamais	3 2 1 0	J'ai l'impression de fonctionner au ralenti : ☐ presque toujours ☐ très souvent ☐ parfois ☐ jamais
0 1 2 3	J'éprouve des sensations de peur et j'ai l'estomac noué : ☐ jamais ☐ parfois ☐ assez souvent ☐ très souvent	3 2 1 0	Je ne m'intéresse plus à mon apparence : ☐ plus du tout ☐ je n'y accorde pas autant d'attention que je le devrais ☐ il se peut que je n'y fasse plus autant attention ☐ j'y prête autant d'attention que par le passé
3 2 1 0	J'ai la bougeotte et n'arrive pas à tenir en place : ☐ oui, c'est tout à fait le cas ☐ un peu ☐ pas tellement ☐ pas du tout	0 1 2 3	Je me réjouis d'avance à l'idée de faire certaines choses : ☐ autant qu'auparavant ☐ un peu moins qu'avant ☐ bien moins qu'avant ☐ presque jamais
3 2 1 0	J'éprouve des sensations soudaines de panique : ☐ vraiment très souvent ☐ assez souvent ☐ pas très souvent ☐ jamais	0 1 2 3	Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission radio ou de télévision : ☐ souvent ☐ parfois ☐ rarement ☐ très rarement
< Total du score pour l'anxiété		< Total du score pour la dépression	

Echelle Doloplus

ÉCHELLE DOLOPLUS® ÉVALUATION COMPORTEMENTALE DE LA DOULEUR		
RETENTISSEMENT SOMATIQUE		
Plaintes somatiques : le patient exprime sa douleur par la parole, les gestes ou des cris-pleurs-gémissements.	pas de plainte	0
	plaintes uniquement à la sollicitation (approche d'un soignant, mobilisation, soins, etc.)	1
	plaintes spontanées occasionnelles	2
	plaintes spontanées continues	3
Positions antalgiques* au repos : position corporelle inhabituelle visant à éviter ou à soulager la douleur.	pas de position antalgique	0
	le sujet évite certaines positions de façon occasionnelle	1
	position antalgique permanente et efficace	2
	position antalgique permanente et inefficace	3
Protection de zones douloureuses : le malade protège une ou plusieurs zones de son corps par une attitude ou certains gestes de défense.	pas de protection	0
	protection à la sollicitation n'empêchant pas la poursuite de l'examen ou des soins	1
	protection à la sollicitation empêchant tout examen ou soin	2
	protection au repos, en l'absence de toute sollicitation	3
Mimique : le visage semble exprimer la douleur à travers les traits (grimaçants, tirés, atones, inexpressifs) et le regard (fixe, absent, ou larmes).	mimique habituelle	0
	mimique semblant exprimer la douleur à la sollicitation	1
	mimique semblant exprimer la douleur en l'absence de toute sollicitation	2
	mimique inexpressive en permanence et de manière inhabituelle (atone, figée, regard vide)	3
Sommeil	sommeil habituel	0
	difficultés d'endormissement	1
	réveils fréquents (agitation motrice)	2
	insomnie avec retentissement sur les phases d'éveil	3

Echelle Doloplus

Mouvements : évaluation de la douleur dans le mouvement pour les changements de position, transferts, la marche, seul ou avec aide.	possibilités habituelles inchangées	0
	possibilités habituelles actives limitées (le malade évite certains mouvements, diminue son périmètre de marche)	1
	possibilités habituelles actives et passives limitées (même aidé, le malade diminue ses mouvements)	2
	mouvement impossible, toute mobilisation entraînant une opposition	3
RETENTISSEMENT PSYCHOSOCIAL		
Communication : verbale et non verbale	inchangée	0
	intensifiée (la personne attire l'attention de manière inhabituelle)	1
	diminuée (la personne s'isole)	2
	absence ou refus de toute communication	3
Vie sociale : repas, animations, activités, ateliers thérapeutiques, accueil des visites, etc.	participation habituelle aux différentes activités	0
	participation aux différentes activités uniquement à la sollicitation	1
	refus partiel de participation aux différentes activités	2
	refus de toute vie sociale	3
Troubles du comportement : agressivité, agitation, confusion, indifférence, régression, demande d'euthanasie, etc.	comportement habituel	0
	troubles du comportement à la sollicitation et de façon répétée	1
	troubles du comportement à la sollicitation et permanents	2
	troubles du comportement permanents (en dehors de toute sollicitation)	3
TOTAL : SCORE/30		

La douleur
n'est pas
une fatalité.

La douleur se prévient.
La douleur se traite.

Traiter votre
douleur,
c'est possible.



Trois éléments fondamentaux vont conditionner le succès des traitements

Comprendre la nature de la douleur

- ❑ De nombreux processus sont capables de créer, d'entretenir, d'amplifier une douleur.
- ❑ Une bonne compréhension de ces facteurs, de leur rôle, est essentielle.

Accepter la réalité de la douleur

- ❑ Il ne suffit pas d'accepter superficiellement, mais d'aller en profondeur.
- ❑ Il faut admettre la douleur dans son ensemble, avec des réactions psychologiques qui l'accompagnent.
- ❑ Il faut accepter la signification de votre douleur, le rôle qu'elle joue dans votre vie.

Adhérer aux traitements prescrits

en faisant confiance et en coopérant avec l'équipe médicale soignante.

PIEGES D'UNE MAUVAISE COMPREHENSION DE LA DOULEUR



Les notions que nous avons développées nous permettent de souligner deux principaux pièges dus à une mauvaise compréhension de ce qu'est la douleur.

1- Le premier piège est que **le caractère subjectif individuel** de la douleur fait que la famille, les amis, les médecins, peuvent vous suspecter et vous accuser d'augmenter la gravité de votre douleur et même d'avoir une douleur imaginaire.

Pourtant votre douleur et votre condition sont bien réelles.

2-Le second piège est lié à la séparation habituellement établie dans notre société entre le corps et l'esprit, entre le somatique et le psychologique.

Une telle séparation ne peut se concevoir pour la douleur chronique.

Cette conception inexacte est cependant fréquente et s'explique par les raisons suivantes.

Dans la majorité des cas, les douleurs que nous éprouvons sont des douleurs de courte durée.

Elles servent de signal d'alarme qui attire l'attention sur une lésion organique (douleurs d'appendicite, douleurs dentaires...).

Les facteurs de la perception psychique de la douleur



Le type de la douleur :

- ❖ Certains types de douleur peuvent engendrer des réactions émotionnelles inappropriées et exagérées.
- ❖ La douleur insidieuse et progressive dans l'intensité peut alarmer et être interprétée comme une annonce d'une maladie éventuellement grave.
- ❖ La répétition et l'intermittence de la douleur peut signifier pour le sujet la récurrence ou l'extension de la maladie ou de son incurabilité.
- ❖ Une douleur brutale et intense peut être alarmante et entraîner une réaction surdimensionnée.

❑ **Les organes cibles de la douleur :**

La douleur au niveau de certains organes nobles ou vitaux et objet de surcharge émotionnelle.

Le lieu ou l'organe concerné par la douleur peut augmenter la réaction émotionnelle telle que la douleur thoracique gauche pour un sujet âgé peut signifier une crise cardiaque.

❑ **L'âge :** Les sujets âgés peuvent réagir à la douleur par de fortes émotions et peur. Une douleur peut signifier une maladie qui peut mettre fin à leur vie. Inversement, les sujets jeunes peuvent minimiser l'importance d'une douleur.

❑ **La maladie :** les malades réagissent avec une forte émotion à la recrudescence des douleurs de certaines maladies notamment graves.

Ces douleurs peuvent signifier pour le sujet l'aggravation de la maladie qui conduit la mort.

❑ **La personnalité :** certaines personnalités anxieuses et narcissiques répondent avec une surcharge émotionnelle à une douleur. Elle est considérée comme une menace à leur intégrité mais aussi à leur image.

□ **Les troubles psychiatriques** : La majorité des psychotiques notamment schizophrénique minimise la douleur et ses risques d'annonce d'une maladie grave.

Les hypochondries et les troubles somatoformes considérés comme des expressions physiques notamment de la douleur sans substratum anatomique sont considérées par les malades comme d'importantes maladies qui peuvent menacer leur intégrité.

□ **La douleur morale** : observée notamment dans les dépressions sévères est une souffrance de malades qui désinvestissent la vie et qui ne voit la mort comme issue de leur souffrance.

Chronicité de la douleur

	Douleur aiguë	↔	Douleur chronique
Finalité Biologique	Utile, protectrice Signal d'alarme		Inutile, invalidante Séquelle, échec
Causes	Trauma, chirurgie, ... Symptôme révélateur		- Lésions évolutives (cancer, rhumatisme, ...) - ou définitives (nerf, ...)
Durée	Transitoire		Durable : - continue - paroxystique
Conséquences Psychologiques	Stress Réaction neuro-végétative		Anxiété Dépression
Evolution Prise en charge	Réversible si cause traitée Répond à un traitement classique « Douleur symptôme »		Auto-aggravation spontanée Retentissement comport. Approche plurimodale multidisciplinaire « Douleur maladie »

REACTIONS PSYCHOLOGIQUES ET DOULEURS CHRONIQUES



▣ Une douleur qui dure depuis plusieurs mois ou plusieurs années, s'accompagne de difficultés psychologiques.

Ce fait est habituel.

Cela ne veut pas dire pour autant que vous êtes un malade mental.

LA DIMENSION PSYCHIQUE DE LA DOULEUR AIGUE



- ❑ La dimension psychique est souvent oubliée , voire totalement ignorée, cependant elle existe réellement.
- ❑ La lésion corporelle accapare toutes les attentions.
- ❑ La plainte douloureuse exprime aussi bien la douleur physique ressentie que la souffrance psychique, mais le patient et le soignant ne les différencient pas.

Constat sur la prise en charge de la souffrance psychique lors de la douleur aiguë



Devant la persistance de la plainte du patient:

- ☐ les soignants n'hésitent pas à augmenter les traitements antalgiques alors que la souffrance psychologique n'est pas prise en compte
- ☐ Si la souffrance psychologique est prise en compte, elle est le plus souvent soulagée par la prescription de médicaments plutôt que par la possibilité d'exprimer son ressenti.

ELEMENTS CONSTITUANT LA PART PSYCHIQUE DE LA DOULEUR AIGUE



- ❑ Choc psychique lors de la lésion (circonstances, état de choc...)
- ❑ Angoisse liée à la maladie, à l'intervention, aux dégâts corporels (devenir, changements de mode de vie, risque vital...)
- ❑ Angoisse due à des douleurs antérieures non calmées qui amène le patient à majorer sa plainte de peur de manquer d'antalgique et ce, tout à fait inconsciemment
- ❑ Psychopathologie sous-jacente pouvant entraîner des réactions exacerbées
- ❑ Facteurs environnementaux :
tout événement concomitant, s'il présente un caractère de gravité peut se répercuter au niveau de son vécu et donc de sa douleur

Prise en charge du patient présentant une douleur chronique



- Tout soignant doit savoir élargir sa compréhension du malade à un ensemble de facteurs psychosociaux susceptibles d'amplifier ou d'entretenir la douleur ou d'entretenir la douleur
- Dans la plupart des cas, la collaboration avec le psychiatre ou le psychologue est souhaitable.
- la difficulté est alors de faire accepter la démarche au malade, démarche qui ne doit pas être interprétée comme la preuve que l'on croit à une douleur imaginaire

Éléments pouvant constituer la part psychique de la douleur chronique



- ❑ **le contexte socio-économique** (assurance, travail) l'aide d'une assistante sociale peut s'avérer utile.
- ❑ **Le contexte familial** (renforcement, rejet, attention...).
- ❑ **le contexte affectivo -émotionnel** (dépression, troubles de la personnalité).
- ❑ **La composante cognitive** (savoir, connaissance) précise la façon dont le patient se représente la cause de sa douleur et son attitude vis-à-vis de la douleur.
Les arrière-pensées et les fausses idées doivent être clarifiées car elles alimentent souvent l'angoisse du patient alors la reformulation de la situation aidera le patient à adopter un comportement plus adapté vis-à-vis de sa douleur
- ❑ **La composante comportementale**
il faut répertorier les diverses manifestations motrices ou verbales témoignant de la douleur lors de l'entretien, lors de l'examen clinique, dans les situations statiques et clinique, dans les situations statiques et dynamiques (mimiques, soupirs, attitudes antalgiques, limitations des mouvements, attitudes guindées...)

conclusions

« La psychologie des conduites nous permet d'ouvrir sur une compréhension de la problématique douloureuse, au-delà de la simple nociception, mais bien d'un comportement appris, mémorisé s'appuyant sur la fonction initiale de la douleur, c'est-à-dire le signalement d'un danger.

Fait incontournable de la condition humaine, très tôt, ce système réflexe sera modulé par une série d'influence (personnel, familial, culturel, sociétal) et amènera chacun à pouvoir mobiliser ses capacités d'adaptation, plus ou moins longtemps, plus ou moins efficacement, surtout quand la confrontation à la douleur dure dans le temps. »

*le psychologue en clinique de la Douleur, (2020) sous la direction de V.BARFETY-SERVIGNAT, S.CONRADI et
A.MASSELIN-DUBOIS, Editions in Press*

conclusions

« Pour en transformer l'expérience, la douleur doit être abordée dans toutes ses composantes et par le recours à différents thérapeutes (et thérapeutiques), avec toujours l'espoir d'en venir à bout. (...) »

L'essentiel du travail thérapeutique se tricote autour de la recherche de sens de la douleur : sens individuel mais aussi collectif ... »

conclusions

Prendre en compte ce qui se passe dans la vie réelle du patient pour mieux le comprendre, l'accompagner dans son parcours et guider les soignants dans leurs décisions cliniques

Penser systémique

Comprendre le patient dans toute sa complexité avec et autour de son équipe de soins

Donner le pouvoir d'agir

Être acteur de sa santé, une clé de voute pour une prise en charge de qualité

Personnaliser la prise en charge

Appréhender le patient dans sa singularité en intégrant les données de vie réelle

Merci pour votre attention!!!!!!